

Ihr autistischer Teenager / Ihre autistische Teenagerin

Für Eltern und familiäre Bezugspersonen — einen autistischen Teenager (etwa 12–18 Jahre) unterstützen.

Die Kernidee

Autismus bedeutet über den **Monotropismus**, dass sich die Aufmerksamkeit Ihres Teenagers in wenige tiefe, intensive „Tunnel“ einschließt. Die Adoleszenz häuft vielspurige Anforderungen — wechselnde Peer-Regeln, Daten, Körperveränderungen, Prüfungen — auf ein System, das schnelles Wechseln als kostenintensiv empfindet. Dies ist das **Spitzenalter für Angst, Depression und Burnout**, und viele autistische Teenager (besonders Mädchen und marginalisierte Geschlechter) werden **erst in der Krise erkannt**. Ihre intensiven Interessen sind Identität, Regulation und Erholung — keine Probleme. Ihre Aufgabe wechselt vom Managen zum *Begleiten*: folgen Sie ihrer Führung, schützen Sie ihren Fokus, senken Sie die Last und nehmen Sie ihr Innenleben ernst.

Was Sie beobachten könnten — und was wirklich dahintersteckt

Sie könnten sehen...	Was oft tatsächlich passiert
Erschöpft, zurückgezogen, „keine Lust“; verweigert die Schule	Wahrscheinlich autistisches Burnout oder Überlastung — von Depression und Faulheit zu unterscheiden
Intensive Interessen; wehrt sich, sie aufzugeben	Interessen sind Identität, Regulation und Erholung — keine Zwänge
Den ganzen Tag „gut“, bricht hinter einer geschlossenen Tür zusammen	Starkes Camouflaging ; die Kosten werden später gezahlt, zu Hause
Selbstverletzung, dunkle Gedanken oder Krise	Reales, erhöhtes Risiko in dieser Gruppe; oft das erste Zeichen unerfüllten Bedarfs
Schwer zu beginnen/zu wechseln; antwortet nicht auf Fragen	Autistische Trägheit + Verarbeitungszeit, keine Unhöflichkeit oder „Nicht-Kümmern“

Versuchen Sie dies

- **Schützen und validieren Sie ihre Interessen** — begrenzen Sie niemals eine gesunde Leidenschaft; sie ist ihre wichtigste Regulation und ein Weg zu Studium, Freund:innen und Erholung.
- **Schaffen Sie Raum zum Entmasken zu Hause** — Zuhause ist der sichere Ort, wo die Schul-Tagesmaske endlich fällt. Rechnen Sie mit einem Nachschul-Zusammenbruch; bauen Sie ruhige, anforderungsarme, interessen-geleitete Zeit ein.
- **Senken Sie Anforderungen, wenn der Tank leer ist.** Wenn es ausbrennt, ist der evidenzgestützte Schritt, **Erwartungen zu reduzieren und Ruhe und Interessen wiederherzustellen** — nicht härter zu drängen.
- **Kommunizieren Sie wörtlich, eins nach dem anderen**, oft schriftlich oder per Text; gewähren Sie Verarbeitungszeit; achten Sie ihre Autonomie in Entscheidungen.

- **Fragen Sie direkt** nach Stimmung, Angst, Schlaf und suizidalen Gedanken mit konkreten Fragen — und hören Sie auf die Antwort.
- **Setzen Sie sich in der Schule ein** (Förderkoordination/SENCO, Bildungs-/Förderplan, ein ruhiger Raum, weniger Übergänge) und planen Sie den Wechsel zu Erwachsenendiensten früh.

Vermeiden Sie dies

- **Autistisches Burnout mit Depression verwechseln** — es als „strenge dich an“ zu behandeln, kann es vertiefen und das Suizidrisiko erhöhen.
- Drängen zum Masken, Blickkontakt oder „sei geselliger“ als Ziel.
- Aktivitäten, Sozialpläne und Erwartungen aufhäufen, wenn sie bereits erschöpft sind.

Wann weitere Hilfe nötig ist

Autistisches Burnout ist real, ernst und eigenständig — chronische Erschöpfung, Kompetenzverlust und verminderte Reiztoleranz; es kann Monate dauern und ist mit Suizidgedanken verknüpft. Begleitende **Angst, Depression, ADHD (AuDHD), Schlaf- und Essschwierigkeiten** sind häufig und verdienen autismus-informierte Versorgung. Suchen Sie eine autismus-positive Klinik, Peer-Gruppen und Mentor:innen — hochwertige Freundschaft ist stark schützend.

Wenn Ihr Teenager ein Mädchen oder ein marginalisiertes Geschlecht ist

Camouflaging gipfelt hier und treibt viel verpasste Diagnose und psychische Kosten. Der „ängstliche, perfektionistische, oberflächlich sozial kompetente“ Teenager kann eine erschöpfte autistische junge Person sein. Fragen Sie gezielt nach **Masking-Erschöpfung** und nehmen Sie ein lebenslanges Muster von Unterschied ernst.

Über diesen Leitfaden

KI-gestützt, abgeleitet aus den Forschungsentwürfen dieses Projekts — der Leitfaden für die **Familie** (Teile 1 & 4) und das **Monotropismus**-Dossier; mit dem Leitfaden für **Praktiker und Gesundheitsfachleute über die Lebensspanne** (Teil 3.3). Verwendet identitätsfirst-Sprache. **Information — kein medizinischer Rat und kein diagnostisches Werkzeug.** Sie kennen Ihren Teenager am besten; passen Sie es an.

Schlüsselquellen. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Raymaker et al. (2020, Burnout); Pearson & Rose (2021, Masking); Bradley et al. (2021, Camouflaging); Edgar (2024). Vollständige Nachweise finden sich in den Quelldossiers.